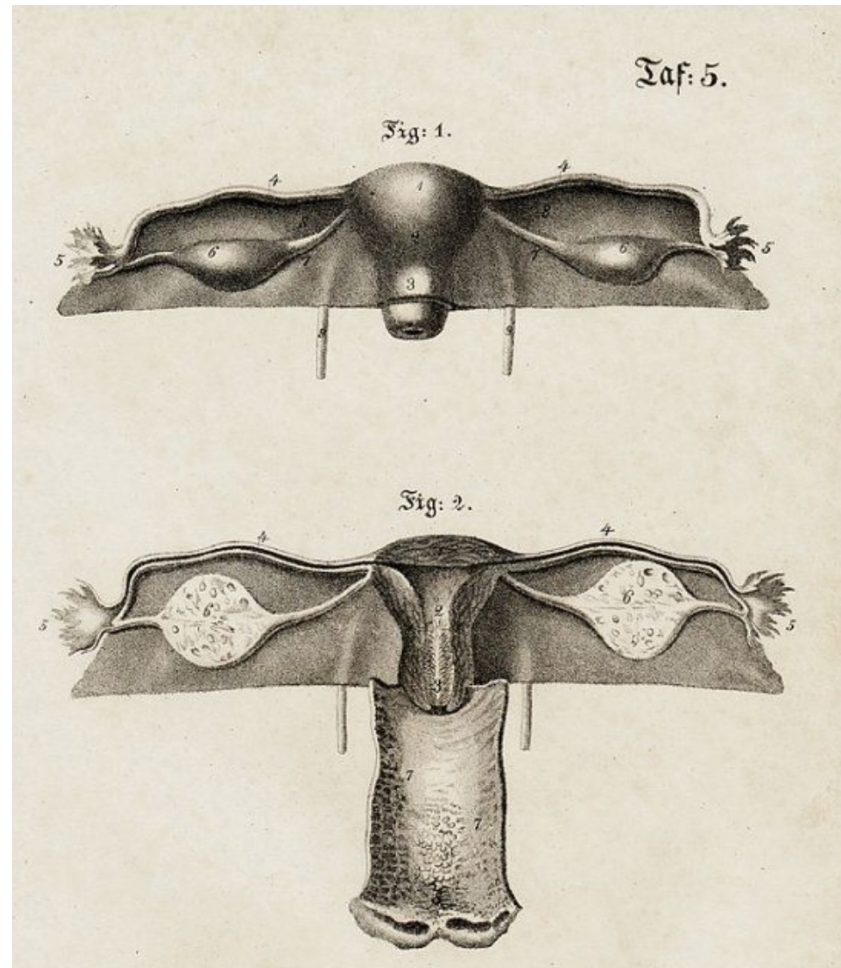
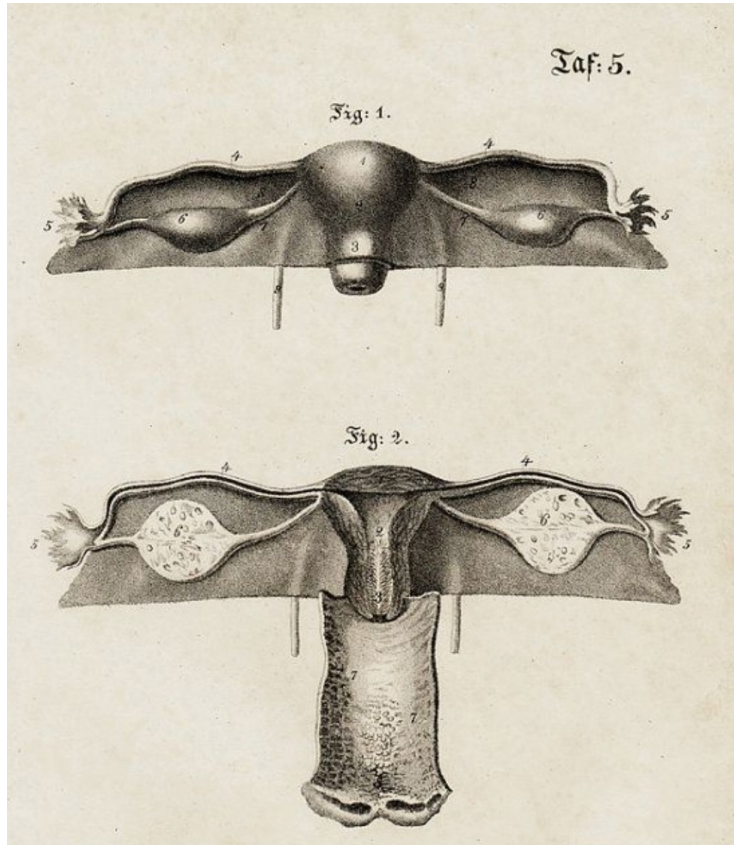


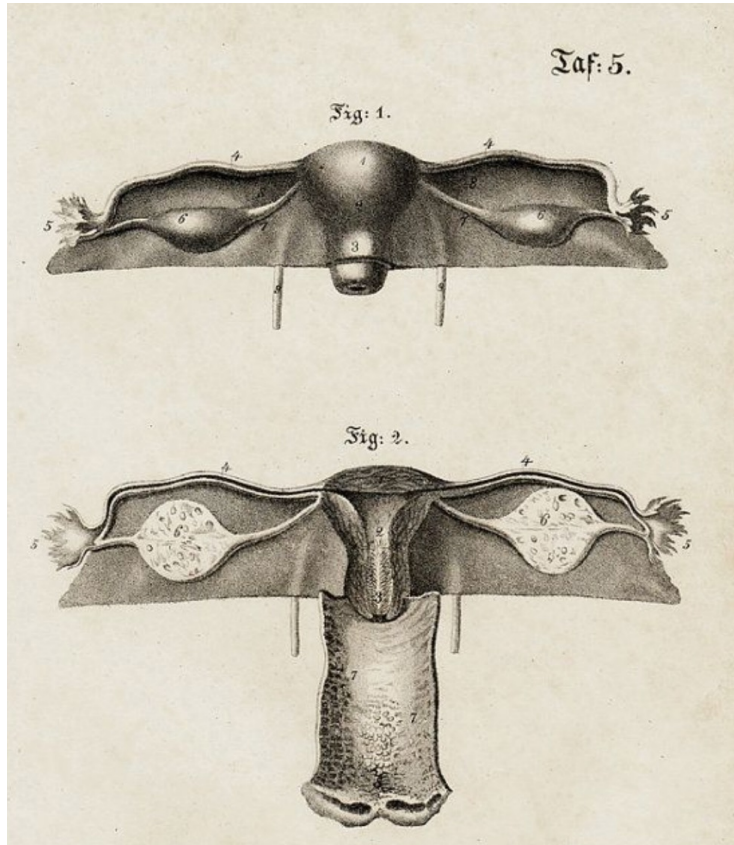
Gynécologie : Pathologies fréquentes





Endométriose :

- **Définition :** Maladie fréquente (2-10% de toutes les femmes, dont seul ¼ sont symptomatiques) et bénigne de la femme en âge de procréer. Se caractérise par la présence de tissus endométriaux ectopiques (en dehors de l'utérus). Les tissus les plus souvent envahies sont les **ovaires**, puis les trompes utérines, la **cloison recto-utérine**, la vessie et le péritoine. Les organes extra-pelviens sont moins souvent touchés (ie poumon). Elle tend à s'améliorer spontanément lors de la grossesse et après la ménopause.
- **Cliniques :** La symptomatologie dépend de la localisation du tissu endométriaux ectopiques. Comme la muqueuse utérine, les tissus ectopiques croissent en réponse aux estrogènes, ce qui peut conduire à des douleurs et la production de médiateurs de l'inflammation, des changements anatomiques en particulier des adhésions (infertilité ou grossesse extra-utérine, dysfonction nerveuse). Les symptômes les plus fréquents sont la **dyspareunie**, la **dysménorrhée**, les **douleurs pelviennes chroniques** et les **troubles de la fertilité**. Les atteintes des ovaires peuvent provoquer des **douleurs en fosse iliaque** et des **maux de dos**. Une atteinte des voies urinaires peut causer des **dysuries**, des infections urinaires à répétition, des **douleurs sus-pubiennes** et des **incontinences**. Des symptômes pulmonaires sont possibles, mais rares (pneumothorax, hémithorax, douleurs thoraciques).
- **Diagnostic :** L'anamnèse (symptômes compatibles, fluctuant et en lien avec le cycle ovarien) et l'examen clinique apportent des indices d'une endométriose. **L'ultrason endovaginal** est le meilleur examen en première intention et peut mettre en évidence des kystes ovariens (couleur « chocolat ») ou des nodules au niveau vésical ou recto-utérin. Une **laparoscopie** et une **biopsie** des lésions sont nécessaires pour poser le diagnostic formel, mais ne sont pas toujours nécessaires si les éléments cliniques et radiographiques sont suffisamment clairs.
- **Traitement :** Médicamenteux en première ligne avec des **AINS ± une contraception orale continue** (COC ou progestatif seul). En deuxième ligne, on peut utiliser ensemble des **GnRHα** et une **COC**. En dernier recours, une opération peut retirer **chirurgicalement** les tissus ectopiques.



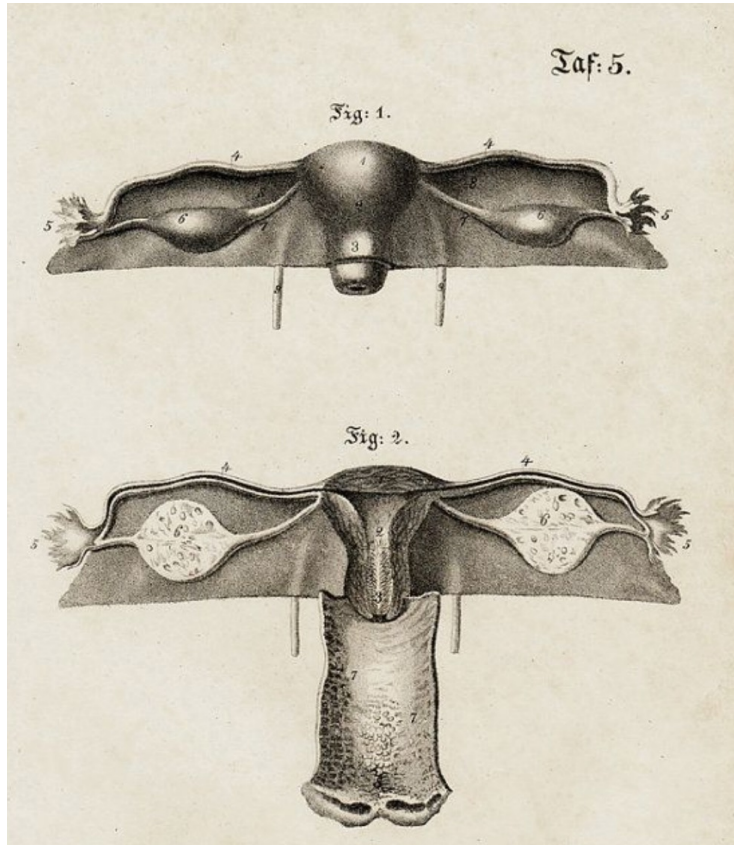
Syndrome des ovaires polykystique :

- **Définition** : L'une des maladies endocrinienne les plus fréquentes (10% des femmes en âge de procréer). La maladie est fortement associée avec l'obésité (cave 20% des patientes touchées ne sont pas obèse) et la résistance à l'insuline, qui causent une hyper-insulinémie et secondairement une augmentation de la production d'androgène par les ovaires et une dérégulation du cycle normal.
- **Cliniques**: Hyperandrogénisme (**hirsutisme**, **acné** et parfois **virilisation**), **troubles de la fertilité** (oligo- ou anovulation), signes de résistance à l'insuline (**surpoids**, **NASH**, **acanthosis nigricans**)
- **Diagnostic**: Après **exclusion des autres endocrinopathies** (hypothyroïdie, Cushing, hyperprolactinémie, hyperplasie congénitale des surrénales) : Au moins 2 des 3 critères suivants
 - **Oligo ou anovulation** : Règles irrégulières, absence de saignements
 - **Hyperandrogénisme** : Acné, alopecie, hirsutisme ou/et **↑ testostérone, androstenedione**
 - **Ultrason** : ovaires **polykystiques** et/ou **élargies**

Cave : Des anomalies à l'US ne sont pas nécessaire pour poser le diagnostic, et on peut avoir un hyperandrogénisme clinique avec un laboratoire dans la norme.
Cave : Un ratio LH:FSH > 2:1 est très évocateurs du PCOS
- **Comorbidité** : Chercher syndrome métabolique (obésité, tour de taille, dyslipidémie, HTA, diabète), et au niveau psychiatrique une dépression ou de l'anxiété. Attention, **risque accru de cancer** (**endomètre**, **ovaire**, pancréas, rein, glandes endocrines).
- **Traitement** : Le PCOS peut entrer en rémission si la résistance à l'insuline est reversée (**perte de poids**, amélioration de **l'alimentation**, **sport**). Traiter les comorbidités si nécessaire.
Un traitement médicamenteux par **COC** peut aider à contrôler l'excès d'androgène (effet anti-virilisation des **progestatifs**) et régularise les cycles : diminution du risque de cancer de l'endomètre, des saignements et de l'hirsutisme. La **metformine** améliore la sensibilité à l'insuline. Pour les femmes souhaitant procréer, le lifestyle et si nécessaire des médicaments pour l'induction de l'ovulation (**létrazole**, un inhibiteur de l'aromatase)

Kyste ovarien:

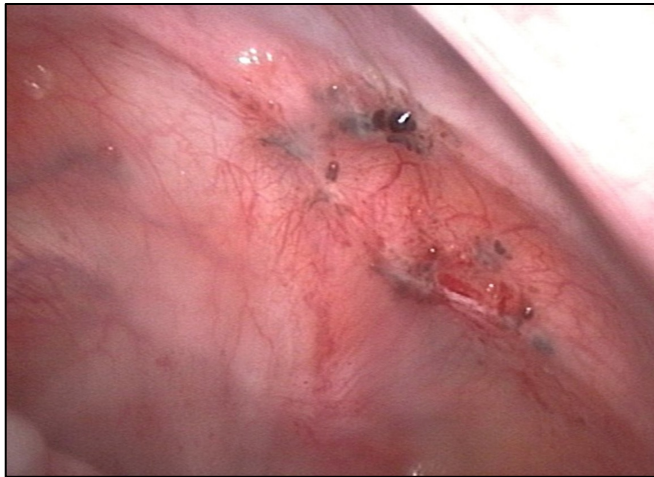
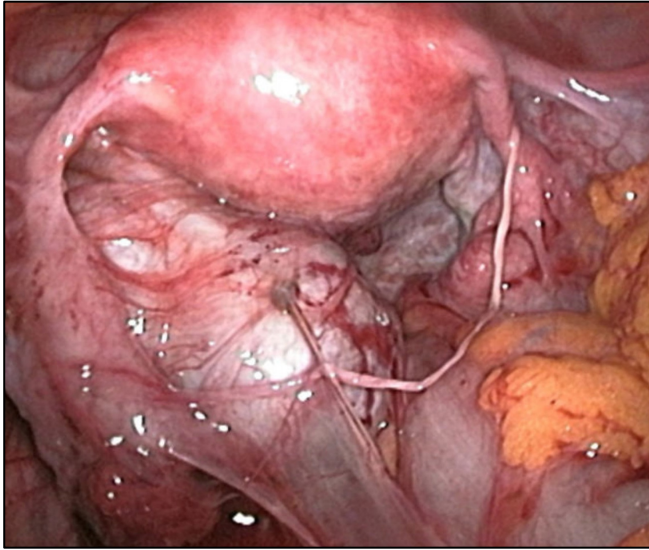
- **Définition** : Kyste rempli de liquide. Dans le cadre d'une endométriose, d'un PCOS ou d'une autre pathologie (kyste non fonctionnelle), ou résultant de l'effet physiologique des hormones durant le cycle (kystes fonctionnelles).
- **Cliniques**: Signes et symptômes de la maladie sous-jacente. Les kystes fonctionnelles sont le plus souvent asymptomatiques et découverts fortuitement. Parfois palpable sous la forme d'une masse.
- **Diagnostic**: Ultrason pelvien
- **Traitement** : Dépend de l'aspect du kyste et de la présence ou non d'une pathologie sous-jacente.
La majorité du temps, un **suivi** suffit mais la **chirurgie** est parfois nécessaire pour éviter une complication dans le futur.



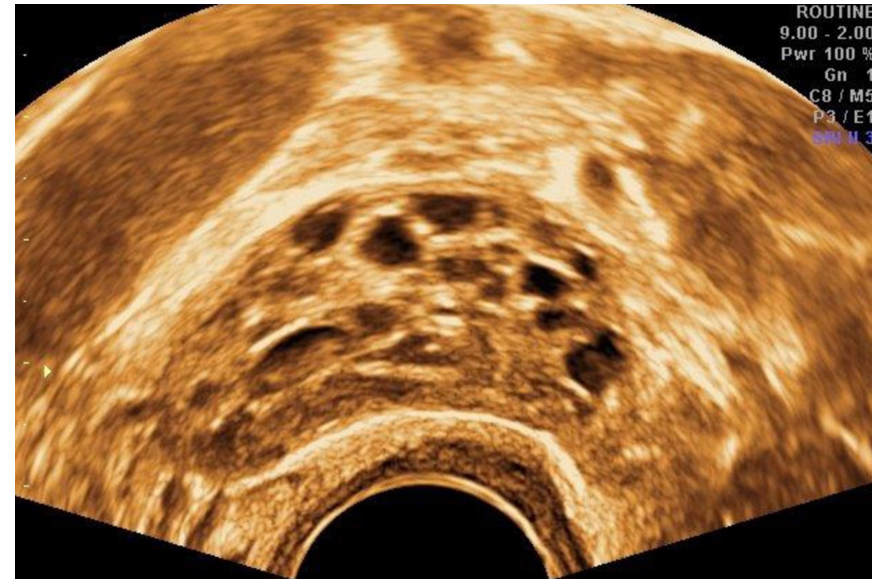
Léiomyome de l'utérus :

- **Définition :** Tumeur bénigne et hormonosensible de l'utérus, de localisation sous-muqueuse, intra-murale ou sous-séreuse. Il s'agit de la tumeur la plus fréquente de l'appareil génital féminin, et elle concerne surtout des femmes en âge de procréer. La symptomatologie s'améliore après la ménopause (diminution des hormones).
- **Cliniques :** Souvent asymptomatique. Parfois compliqué de **ménorragie** importante avec **dysménorrhées** ou de troubles de la fertilité.
- **Diagnostic :** L'ultra-son endovaginale et abdominale est le meilleur examen de premier choix et permet de mettre en évidence des **zones hypoéchogènes** correspondant à la tumeur.
- **Traitement :** En présence d'une clinique peu invalidante, le **suivi simple** sans traitement suffit. Si nécessaire, la pose d'un **stérilet** ou une **contraception orale** (COC ou progestatif seul) pour soulager les symptômes. Dans les cas où cela ne suffit pas, il est possible **d'emboliser par radiologie interventionnelle** les vaisseaux vascularisant la tumeur ou de réséquer tout ou partie de l'utérus **chirurgicalement**.

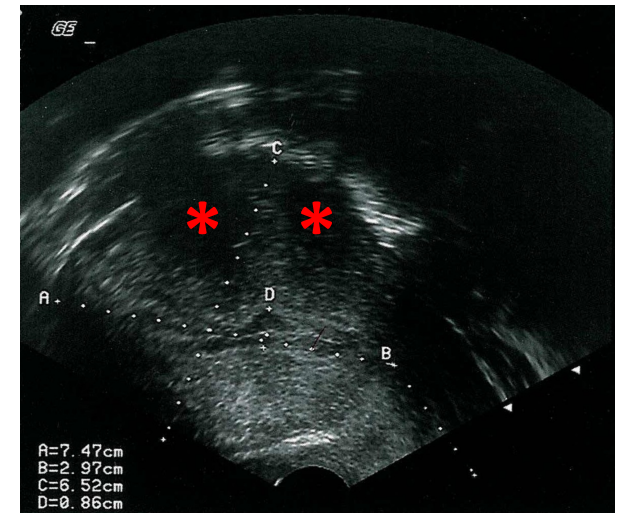
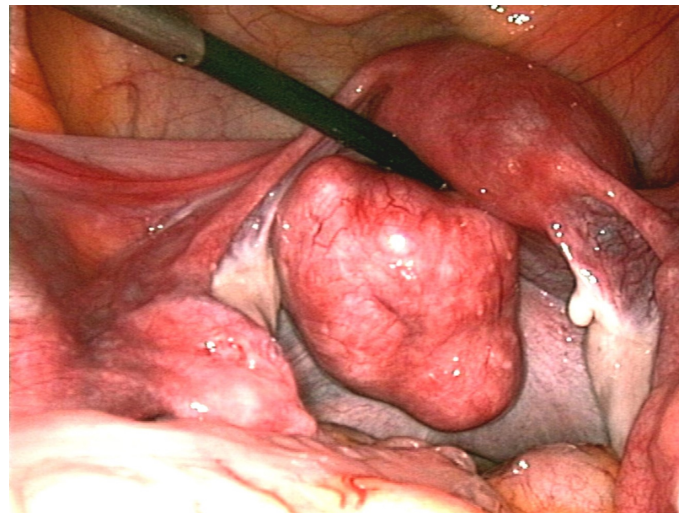
Endométriose

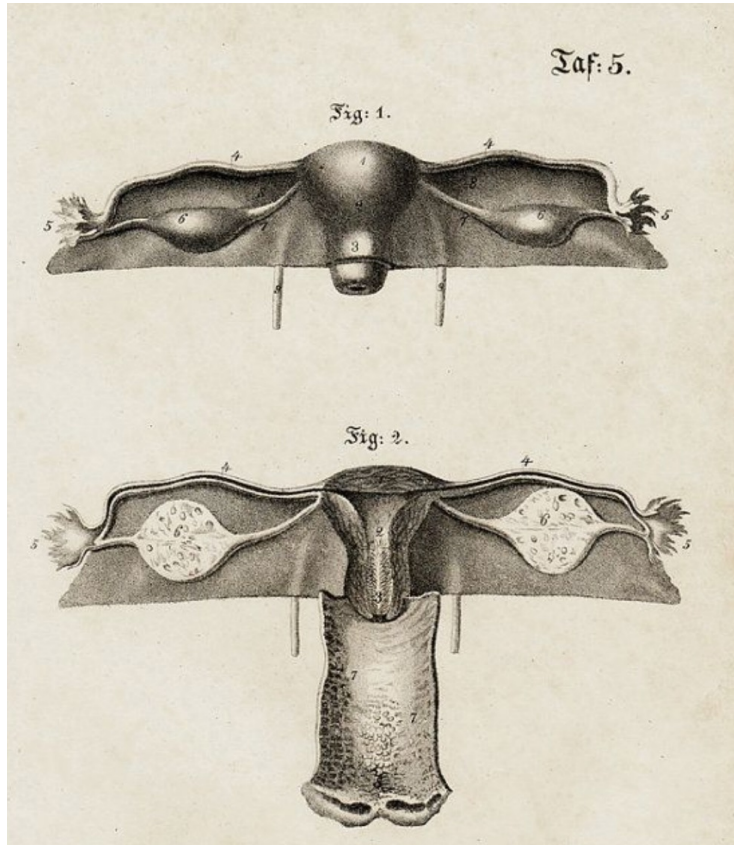


PCOS



Léiomyome utérin





Cave: Pas oublier **C. trachomatis** et **N. gonorrhoeae**, qui peuvent également provoquer des pertes vaginales

Vulvo-vaginite infectieuses :

- **Vaginose bactérienne :**

- Jusqu'à 50% des vulvo-vaginite (cause la plus fréquente)
Infection à **Gardnerella vaginalis** souvent avec d'autres germes (*Prevotella* spp. , *Mycoplasma hominis*...).
- La prolifération de *G. vaginalis* et d'anaérobies est favorisée par la disparition du **Lactobacillus acidophilus**
- **FR** : Rapports sexuelles, stérilet, excès de lavage au niveau vaginal (déplétion flore normale), grossesse
- **Clinique** : Souvent asymptomatique. Écoulement vaginale en général blanchâtre avec une odeur de poisson.
Rarement, présence de prurit ou de douleur
- **Diagnostic** : Au moins 3 des 4 **critères de Amsel** (*Clue cells*, $pH > 4.5$, *Positive amine test*, *Perte vaginale grise, blanchâtre ou jaunâtre adhérent à la paroi du vagin*)
- **Traitement** : Aucun si asymptomatique (en général résolution spontanée),
Si symptomatique : **métronidazole** ou **clindamycine** intravaginale (ou PO)
- **Complications** : Accouchement prématuré, fausse couche

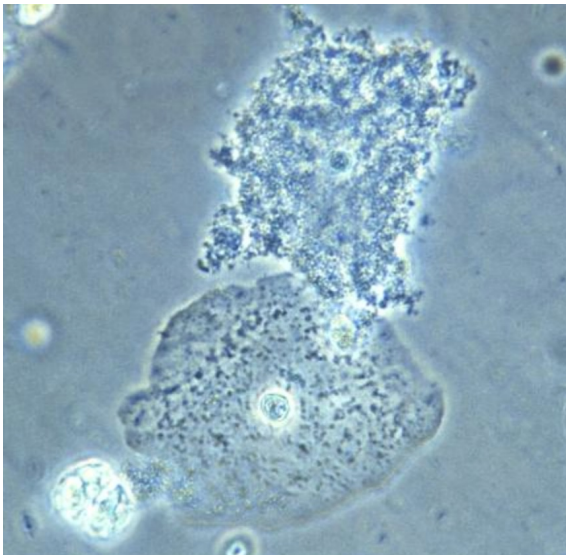
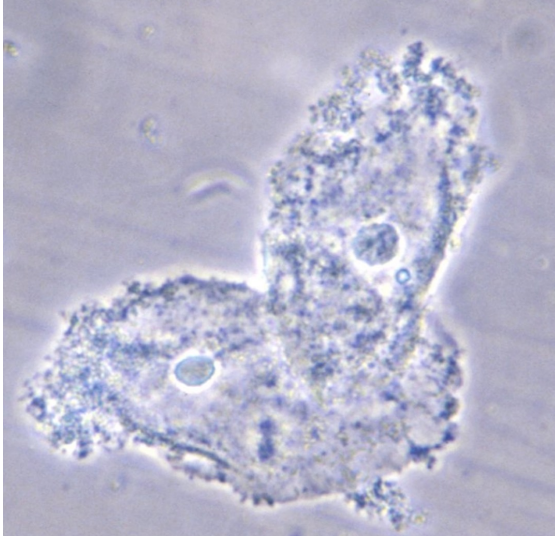
- **Vaginose fongique :**

- Jusqu'à 30% des vulvo-vaginite (seconde cause la plus fréquente)
- Infection à **C. albicans** (parfois *C. glabrata* chez l'hôte immunosupprimé)
- **FR** : grossesse, antibiotique, immunodéficience (systémique ou locale)
- **Clinique** : Écoulement vaginale blanchâtre avec des grumeaux, inodore. Erythème de la vulve.
Fréquemment prurigineux et douloureux, dyspareunie et dysurie
- **Diagnostic** : pH normal (acide, < 4.5), visualisation de pseudo-hyphes au microscope
- **Traitement** : **Triazolé topique** ou une dose de **fluconazole PO**.
Cave pas de fluconazole PO pour les femmes enceintes

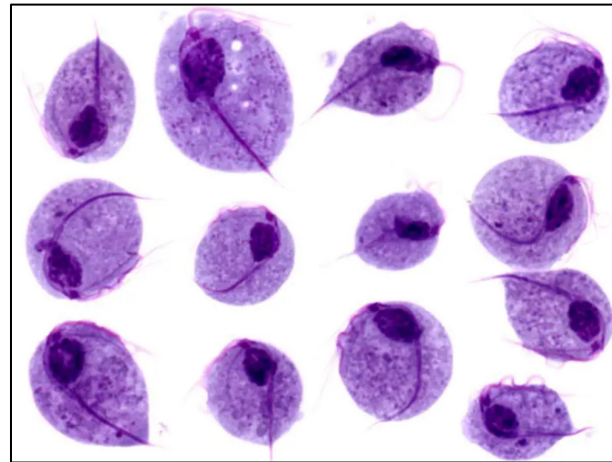
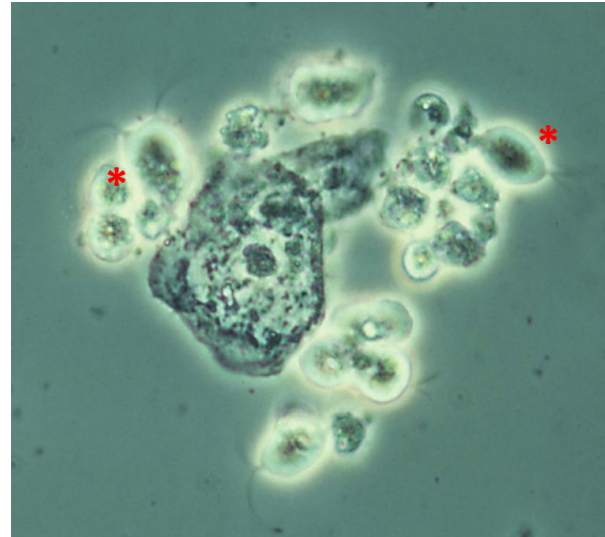
- **Trichomonase :**

- Jusqu'à 20% des vulvo-vaginite (troisième cause la plus fréquente)
- Infection au parasite anaérobie **T. vaginalis**
- **FR** : grossesse, antibiotique, immunodéficience (systémique ou locale)
- **Clinique** : Écoulement vaginale jaunâtre et malodorant. Erythème de la vulve.
Fréquemment prurigineux et douloureux, dyspareunie et dysurie.
Col de l'utérus érythémateux avec des pétéchies (« strawberry cervix »)
- **Diagnostic** : pH normal (acide, < 4.5), visualisation de **parasites flagellés** et mobiles au microscope.
Si nécessaire, **culture** ou **PCR**
- **Traitement** : **Metronidazole PO (7 jours)**
Traiter aussi le partenaire (7 jours si ♀, monodose 1si ♂)
- **Complications** : Accouchement prématuré, fausse couche, retard de croissance intra-utérin

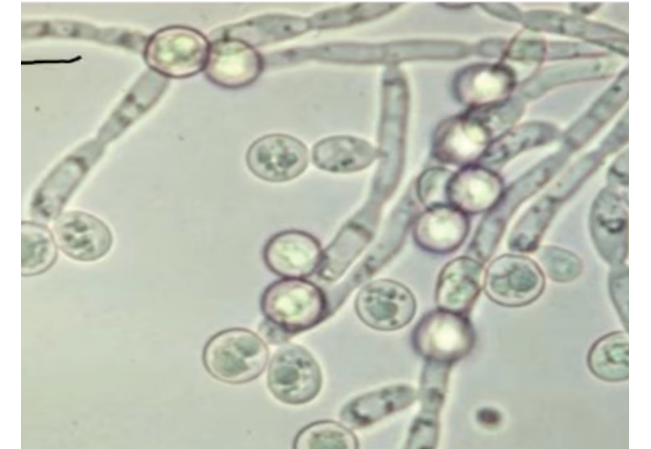
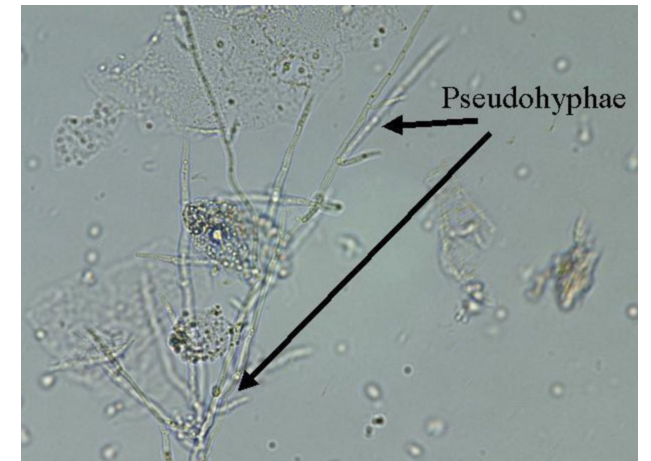
Clue cells

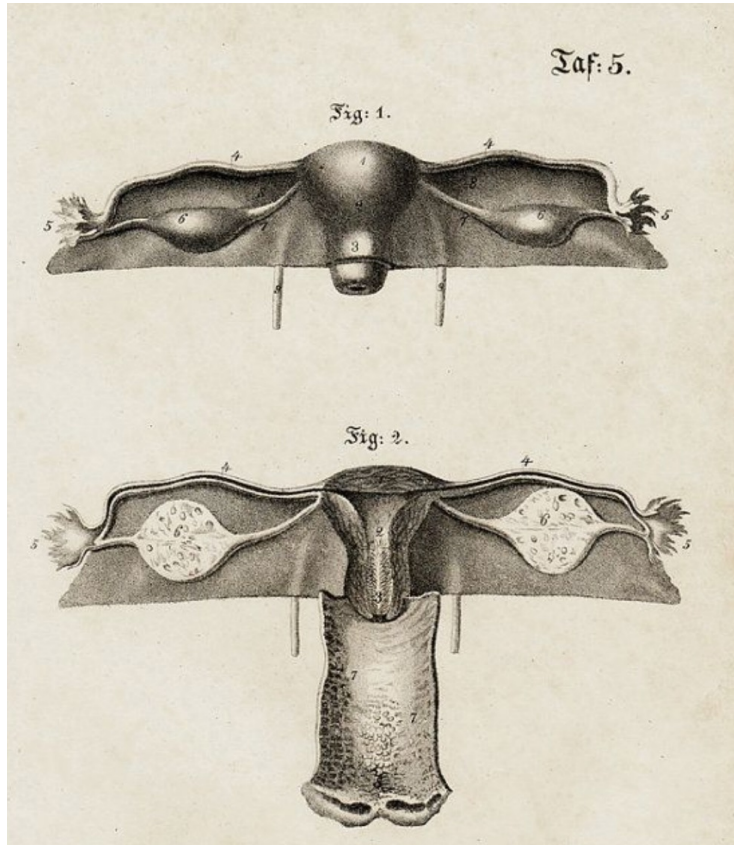


Trichomonase



Vaginose fongique





Vulvo-vaginite non infectieuses :

- Syndrome génito-urinaire de la ménopause :

- Atrophie de la muqueuse secondaire à la diminution de la production d'oestrogène après la ménopause. Peut également survenir après une ovariectomie bilatérale ou durant la grossesse/lactation
- **Clinique : Sécheresse vaginale**, dyspareunie, infection urinaire récurrente, **perte vaginale**, parfois **spotting**
- Diagnostic : Clinique (symptômes, contextes, signes)
- **Traitement : Crème hydratante**, si nécessaire **œstrogène topiques ou systémiques**

- Vaginite aérobie:

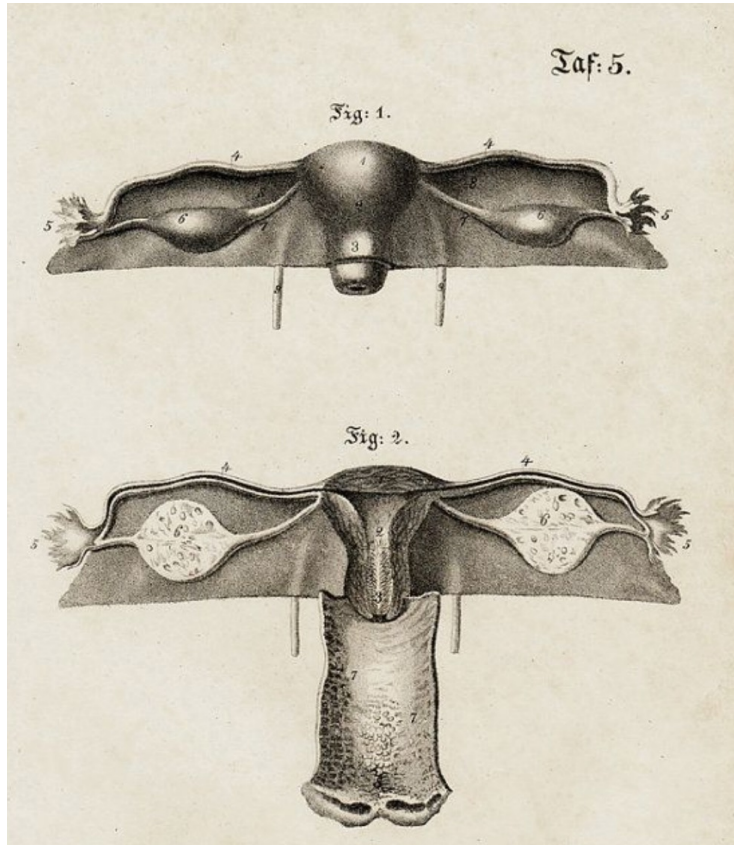
- Primairement une perturbation non-infectieuse microbiote avec secondairement une surinfection bactérienne
- Environ 10% des vaginites chroniques, concerne plus volontiers les femmes en péri ou post-ménopause
- Toujours une combinaison **d'infection, d'atrophie** et de **dysbiose**
- **FR** : grossesse, antibiotique, immunodéficience (systémique ou locale)
- **Clinique : Écoulement** vaginale jaunâtre et malodorant. Erythème de la vulve et du vagin. Fréquemment prurigineux et douloureux, dyspareunie et dysurie.
- **Diagnostic** : pH anormal (> 4.5), test aux amines négatif, leucocytes à la microscopie
- **Traitement : En fonction de l'importance de chacun des trois facteurs**
Infection → **antibiotique** selon culture (FQ, amoxiciline...)
Dysbiose → **Probiotiques oraux**
Atrophie → **Oestrogènes topiques**
- **Complications** : Accouchement prématuré, fausse couche, chorioamniotite...

- Vulvo-vaginite allergique :

- Concerne en particulier les filles pré-pubères
- Hypersensibilité à la lingerie, au liquides de nettoyages etc...
- **Clinique** : Pas d'écoulement. Prurit, érythème, rougeur,
- **Diagnostic** : Test cutanée, recherche de sensibilisation à la prise de sang...
- **Traitement : Éviction de l'allergène**, crème à la cortisone si nécessaire

- Vulvo-vaginite mécanique :

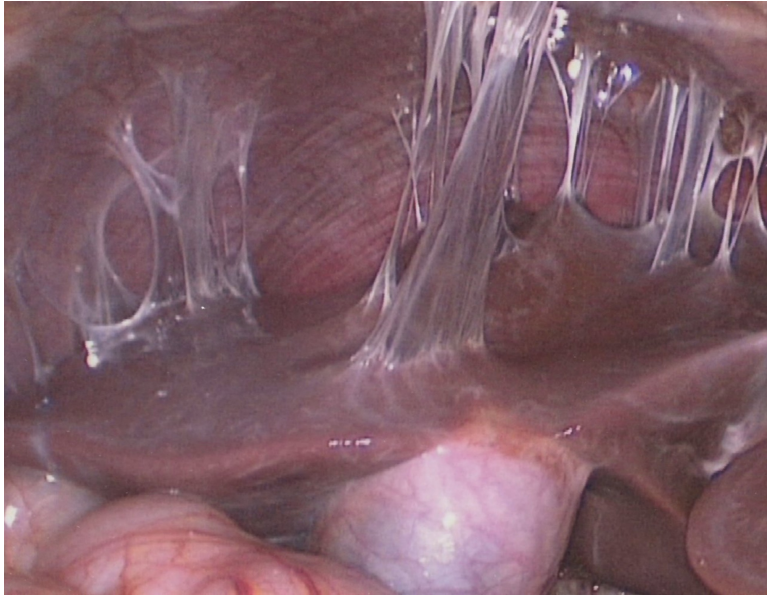
- Stress mécanique primaire ou secondaire à une maladie (dermatite atopique, psoriasis, lichen scléreux,)
- Hypersensibilité à la lingerie, au liquides de nettoyages etc...
- **Clinique** : Pas d'écoulement. Prurit, érythème, rougeur, dyspareunie, dysurie
- **Diagnostic** : En fonction de la cause suspectée
- **Traitement** : En fonction de la cause suspectée



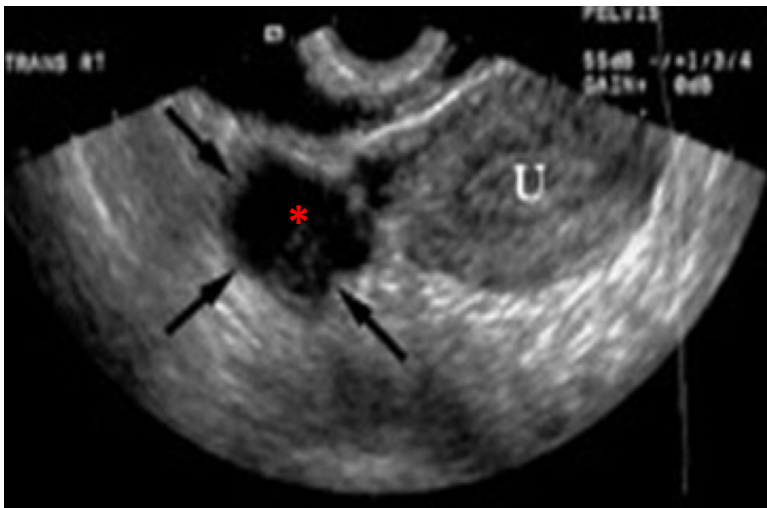
Pelvic inflammatory disease (PID) :

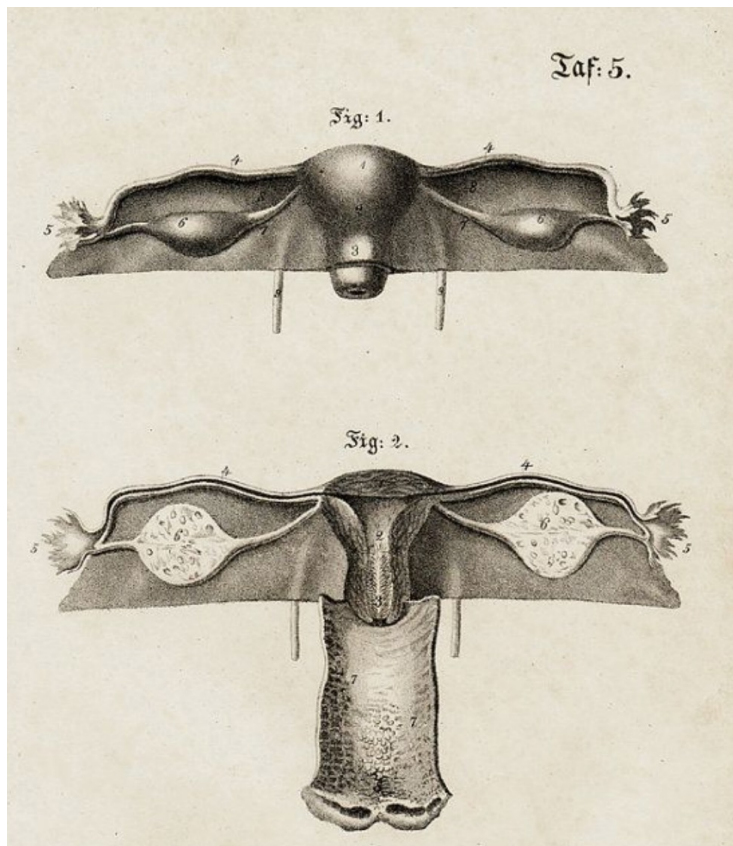
- **Définition :** Infection bactérienne de l'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires et les tissus adjacents
=> cervicite, endométrite, salpingite, oophorite, péritonite...
Principalement causée : **C. trachomatis** et **N. gonorrhoeae** (aussi *Ureaplasma*, *E. coli*, *Mycoplasma*, **anaérobies**...)
C'est une infection fréquente (life-time prevalence 5%) et l'une des premières causes d'infertilité.
- **FR :** Multiples partenaires sexuelles, sexe non protégé, stérilet, dysbiose vaginale
- **Cliniques :** Douleurs abdominales basse, **nausées, vomissements, fièvre**, dysurie, urgence mictionnelle, dyspareunie, **écoulement vaginal**, ménorragie et métrorragie
- **Diagnostic :** Initialement clinique. Anamnèse et contexte compatible, visualisation d'un écoulement purulent à l'examen gynécologique. Exclusion d'une grossesse ectopique (b-HCG). L'ultra-son permet d'exclure d'autres diagnostics différentiels (rupture de kyste, appendicite, torsion ovarienne) et d'évaluer la présence d'abcès ou de liquide libre. Confirmation du diagnostic par examen microbiologique de l'écoulement (PCR, culture, microscopie).
- **Traitement :** **Ceftriaxone IM** (mono-dose) + **Doxycycline** + **Métronidazole** 14 jours
- **Complication :** À court terme : extension au péritoine (**péritonite**), **Fitz-Hugh-Curtis** (péri-hépatite)
À long terme : **Infertilité**, grossesse ectopique, douleurs pelviennes chroniques

Fitz-Hugh-Curtis



***Abcès tubo-ovarien**





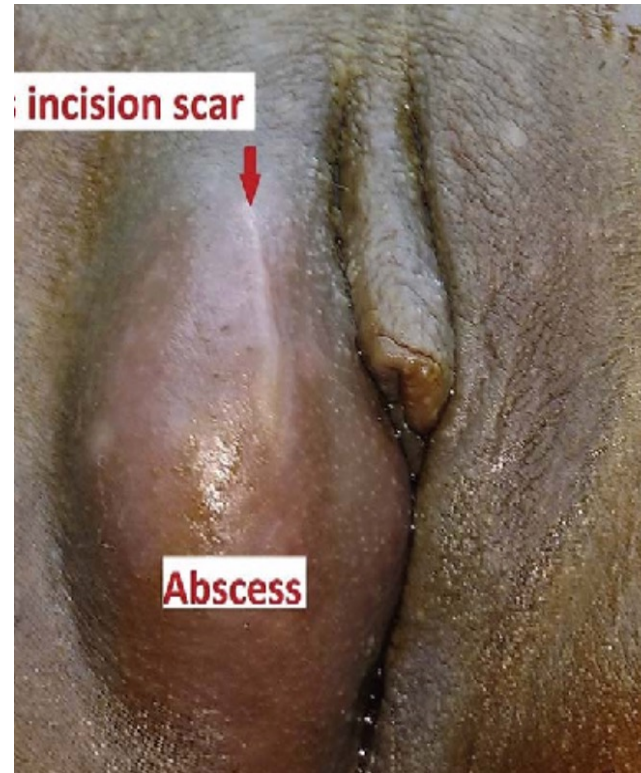
Abcès et kystes des glandes de Bartholin :

- **Définition :** Occlusion d'une glande de Bartholin, situé au dans la moitié inférieure des petites lèvres. L'occlusion peut-être avec (abcès) ou sans (kyste) surinfection bactérienne. Life-long prevalence d'environ 2%.
 - Kyste : Le DD est un cancer de la glande de Bartholin qu'il faudra parfois exclure par une biopsie.
 - Abcès : La surinfection est le plus souvent polymicrobienne avec *E.coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *N. gonorrhoeae* et *C. trachomatis*.
- **Cliniques:**
 - Le kyste est le plus souvent asymptomatique et provoque parfois des dyspareunies.
 - L'abcès est plus tapageur et provoque des **douleurs**, un **œdème** et un **érythème**, parfois de la fièvre (20%), et un soulagement immédiat des symptômes après drainage.
- **Diagnostic:**
 - Kyste : Le diagnostic est clinique. Attention toutefois à toujours **effectuer une biopsie** si un de ces critères est présent : âge > 40 ans, non réponse au traitement, masse croissante, antcd de cancer labiaux
 - Abcès : Le diagnostic est avant tout clinique. La culture du liquide après incision/drainage permet d'identifier les germes en causes. Possible recherche des MST (chlamydia et gonocoque parfois en cause).
- **Traitement :**
 - Si suspicion de malignité : Excision, envoie en pathologie
 - Kyste < 3 cm : Traitement conservateur avec bains et compresses chaudes
 - Kyste >3 cm et abcès (toutes tailles) : **Incision, drainage** puis **marsupialisation**
 - Abcès récidivant ou avec cellulite : **Co-amoxicilline** (ou clindamycine) 5 jours

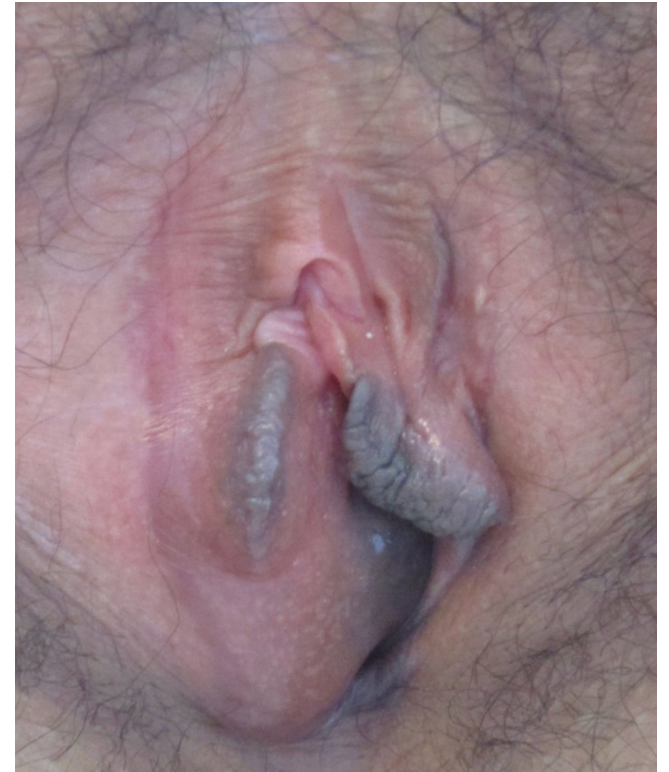
Carcinome

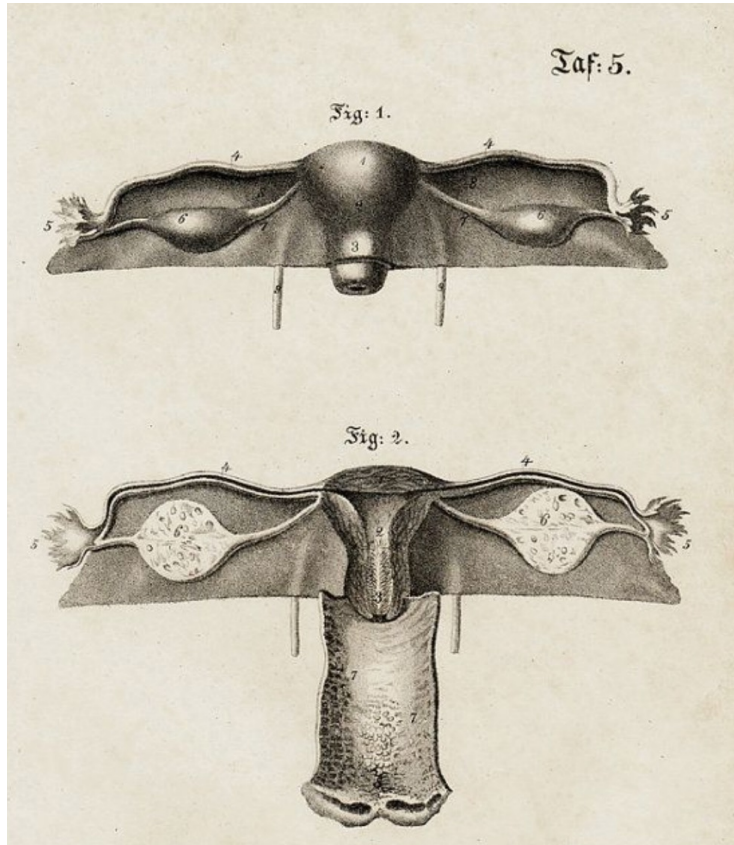


Abcès



Kyste



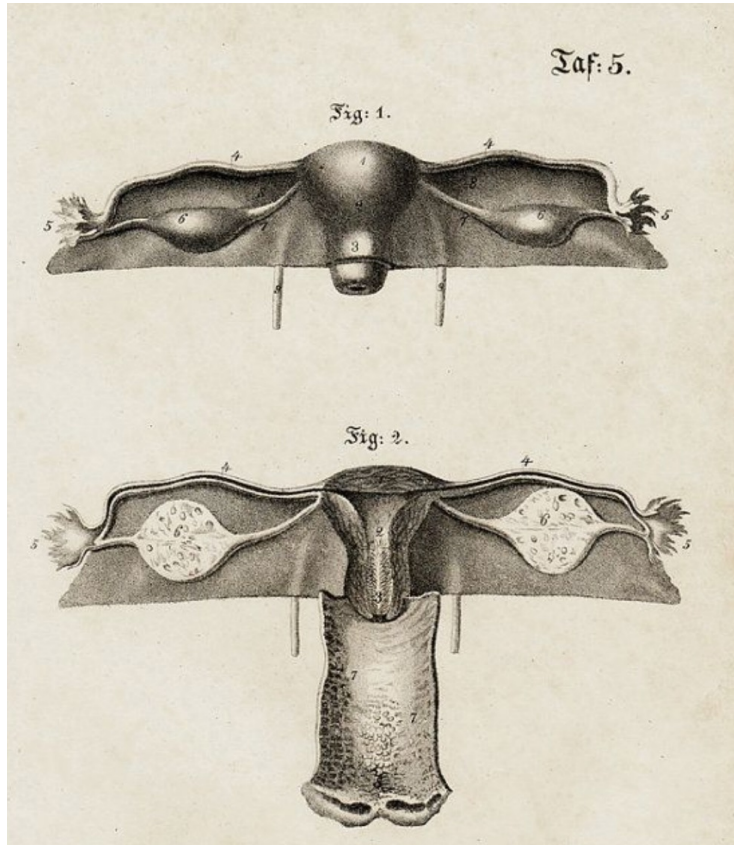


Cancer de l'endomètre :

- **Définition** : Le cancer des voies génitales féminine le plus fréquent. Pic d'incidence entre 55 et 65 ans.
- **FR** : Longue exposition hormonale (nuliparité, longue ménarche, obésité postménopause ou PCOS)
- **Cliniques**: **Métrorragie** ou saignement chez une **femme ménopausée** sans autres symptômes. Tardivement, le cancer peut provoquer des douleurs pelviennes et une masse peut-être palpée.
- **Diagnostic**: **Ultrason** trans-vaginale (endomètre >4 mm) et **biopsie** endométriale.
- **Traitement** : Le plus souvent, **hystérectomie** avec **salpingo-ovariectomie bilatérale** ± RT, CT, HT

Tumeurs des ovaires :

- **Cliniques**: En fonction du tissus touchés dans l'organe, différents types de tumeurs épithéliales ou germinales, malignes ou bénignes sont possibles. Les tumeurs ovariennes sont la première cause de masse ovarienne chez les femmes de >55 ans. Le **CA-125** est un marqueur tumoral de de cancer ovarien, mais peut aussi être élevé dans l'endométriose ou la cirrhose (élevé chez une jeune → endométriose; chez une personne âgé → cancer)
- **FR** : Génétique (BRCA, HNPCC, histoire familiale), longue période de ménarche et absence de grossesse/allaitement. Le nombre de grossesses, une longue période d'allaitement et l'utilisation d'une COC sont des facteurs protecteurs.
- **Clinique** : **Typiquement asymptomatique**, ou symptômes non spécifiques : ballonnement, satiété précoce, douleur pelvienne, ascite et **distension abdominale** (épanchement malin), thrombose (syndrome de Trousseau), urgences mictionnelles...
- **Diagnostic**: L'ultrason est le premier examen en cas de suspicion, auquel on rajoutera un laboratoire avec le dosage du CA-125 qui est élevée dans 80% des cas de cancer. En cas de doute, il faut procéder à une évaluation voir une résection chirurgicale **sans biopsie** (risque de dissémination).
- **Traitement** : **Chirurgie** et **chimiothérapie**



Cancer de la vulve et du vagin :

- **Définition :** Cancer **rare** des appareils génitaux externes se rencontrant plus fréquemment chez la femme post-ménopausée. 85% de **carcinome épidermoïde**, 15% d'adénocarcinome (cave associée au Paget vulvaire)
- **FR :** Infection **HPV** (16, 18, 31, 33), tabac, **dystrophie** valvulaire ou **néoplasie** intra-épithéliale, antcd **lichen scléreux**
- **Cliniques:** Lésion nouvelle, excroissance verruqueuse ou ulcère, prurit, parfois saignement. Parfois présentation sous la forme d'un eczéma (Maladie de Paget de la vulve).
- **Diagnostic:** Examen clinique, colposcopie et surtout **biopsie**
DD : Lichen scléreux et néoplasie intra-épithéliale (cave précancéreux)
- **Traitement :** Mauvais pronostic. Le traitement de base consiste en une **vulvectomie radicale** ± RT et CT

Cancer du col de l'utérus :

- **Définition :** Cancer fréquent (3e cancer gynécologique) avec un pic d'incidence entre 35– 45 ans. La lésion pré-cancéreuse (CIN) se développe le plus fréquemment entre 25 et 35 ans. Le plus souvent de type **carcinomes épidermoïdes**. Le screening (dépistage opportuniste) par **PCR HPV** et **examen cytologique** permettent un diagnostic précoce, et le cancer peut-être prévenue par la vaccination HPV.
- **FR :** Infection HPV, tabac, immunosuppression, néoplasie intra-épithéliale cervicale (CIN).
- **Cliniques:** Asymptomatique en phase précoce (notamment CIN). Plus tard se développe des symptômes tel que des **pertes vaginales** anormales (sanguinolente ou malodorante), une **dyspareunie** et un **spotting post-coïtal**, des douleurs pelviennes.
- **Diagnostic:** Colposcopie, cytologie et si nécessaire biopsie.
- **Traitement :** Combinaison de chirurgie, radiothérapie,

Lichen scléreux

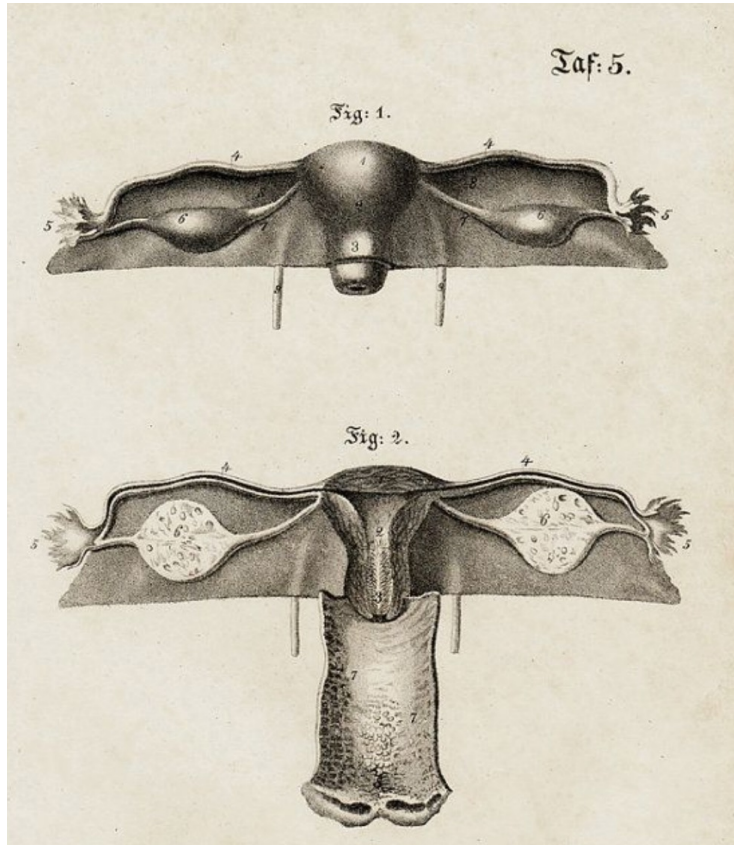


Cancer vulvaire



**Maladie de Paget
De la vulve (eczéma)**





Cancer du sein :

- **Définition :** Second cancer le plus fréquent chez la femme. Life-time prévalence >10%. Le plus souvent diagnostiqué grâce aux mammographies de screening (dès 50 ans)
- **FR :** Augmentation de l'exposition aux estrogènes (nulliparité, absence de lactation, longue période de ménarche, obésité postménopause [aromatase dans tissus adipeux], COC ou substitut hormonaux), âge avancé, prédisposition génétique, style de vie (pauvre en fibre, riche en gras, tabac, consommation d'alcool)
- **Cliniques:** Asymptomatique initialement. Développement d'une **masse**, d'abord uniquement palpable puis provoquant une asymétrie des seins. Rétraction de la peau ou « **peau d'orange** », décharge du mamelon ou rétraction. **Œdème du bras**, **adénopathies** axillaires et supra/infra-claviculaire. **Eczéma** du mamelon, **ulcère** de la paroi du sein. Signes de métastases : **douleurs osseuses**, dyspnée/hémoptysie/douleurs thoraciques, signes d'atteintes hépatiques, déficit neurologiques/céphalées positionnelles/signes d'HTIC.
- **Diagnostique:** **Mammographie** uniquement pour le screening des patientes asymptomatiques (le plus souvent), rajouter un **US** du sein en cas de d'anomalie clinique (US seul si patiente < 30 ans). Si présence de masse, effectuer une **biopsie** puis si nécessaire un bilan d'extension (IRM des seins pour le staging local, scintigraphies osseuses + CT ou PET-CT seul pour le staging à distance)
- **Traitement :** En fonction de la biologie de la tumeur + stade TNM => Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblé...

Mastite infectieuse et abcès du sein :

- **Définition :** La mastite infectieuse est une infection du sein et des tissus adjacents, touchant le plus souvent des femmes en période d'allaitement (**mastite puerpérale**, concerne 10% des femmes). Plus rarement, elle peut survenir chez une femme non allaitante (**mastite non puerpérale**, rare). Le germe le plus fréquemment mis en cause est le **S. aureus** (plus rarement : *E. coli*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium*, *Mycobacterium spp.*) L'abcès du sein peut compliquer les deux types de mastites.
- **Cliniques:** Sein chaud, érythémateux, œdématié et douloureux. S'accompagne volontiers de fièvre.
- **Diagnostique:** Le plus souvent uniquement clinique. Lors de mastite sévère ou de non-réponse à la thérapie initiale, on peut envisager de **cultiver** le lait et un **US** (ou mammographie) afin d'exclure un abcès sous-jacent.
- **Traitement :** Lors d'une mastite puerpérale, le traitement initial (24 premières heures) est conservatif, avec l'application de compresse chaude et froide ainsi que le maintien de la lactation (permet d'éviter la stagnation du lait et la formation d'un abcès, sans risque pour le nourrisson). En cas de non amélioration après 24h ou de mastite non puerpérale, une antibiothérapie empirique (précédé dans les cas sévère d'une prise de lait et de sa mise en culture) par **co-amoxiciline po** 7 jours est recommandé (clindamycine ou bactrim si suspicion de MRSA, vancomycine IV dans les cas sévères). Lors d'une évolution défavorable avec formation d'un abcès, un **drainage** avec mise en culture sont indiqués, de même qu'une AB par **co-amoxiciline IV** (≥ 7 jours)

Mastite



Abcès (US)

